Cálculo de colédoco que migrou. Hepatite, improvável. O controle das 15h30 decide.

Mulher de 50 anos, colecistectomizada há 9 anos. Dor biliar súbita, transaminases que dispararam em horas com GGT dez vezes o limite, bilirrubina normal e via biliar fina na tomografia: é o retrato do cálculo que atravessou a papila. A leucocitose que cai após uma dose de ceftriaxona fecha colangite leve, já resolvendo. Falta provar que não ficou cálculo para trás.

BILIRRUBINA TOTAL

0,8

Dosada uma vez, até 6 h após a dor

Cedo demais para excluir obstrução: a bilirrubina sobe mais devagar que as transaminases e não foi repetida em D1.

ALT (TGP)

281

Subiu de 188 em um dia

Padrão hepatocelular agudo (índice R acima de 5), cerca de 7 vezes o limite habitual de 40 U/L. AST foi de 292 a 299: parou antes da ALT, como quando a agressão cessa.

LEUCÓCITOS

14,5 mil

Caiu de 18,8 mil em 24 h

Inflamação sistêmica que responde. Com enzimas hepáticas altas, preenche "colangite suspeita" de Tóquio 2018, grau leve; Charcot falta em 3 de 4 colangites.

O que o quadro tem, e o que não tem

A favor do cálculo que migrou tem

- Dor epigástrica súbita, para o dorso, que cede em horas: dor biliar típica
- AST acima da ALT nas primeiras horas, ALT na frente no dia seguinte: lesão aguda que já cessou
- GGT dez vezes o limite com fosfatase alcalina ainda normal: a FA demora dias
- Leucocitose neutrofílica que cai com a desobstrução

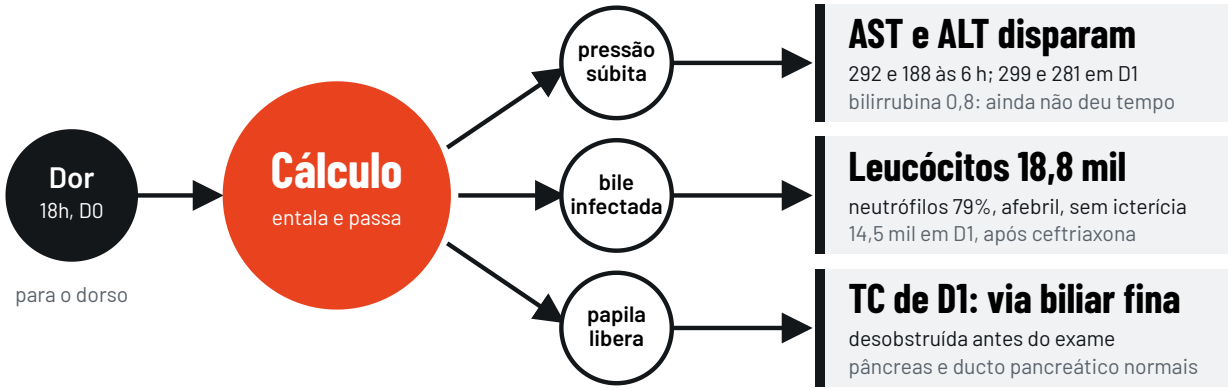
Contra hepatite aguda não tem

- Pródromo de febre, mal-estar e náusea, típico da hepatite A
- Icterícia: atinge mais de 70% dos adultos com hepatite A
- ALT subindo por dias; aqui a AST liderou cedo e já parou em D1
- Fármaco: a dipirona veio depois da dor, e sua lesão leva semanas
- Hipotensão ou choque, que a hepatite isquêmica exige

Pancreatite saiu do mapa: lipase 52,6 nas primeiras 6 h e pâncreas normal na TC de D1; a lipase das 15h30 fecha. Hepatites B e C não reagentes nos testes rápidos; falta o anti-HAV IgM, que o Ministério da Saúde põe em toda sorologia de hepatite.

O cálculo passou. A tomografia chegou tarde para vê-lo.

A sequência explica cada exame. O cálculo entala na papila, a pressão na via biliar sobe de repente e o fígado libera transaminases em horas, não em dias. Quando o cálculo atravessa, o colédoco volta ao calibre normal antes da tomografia e a bilirrubina nem chega a subir. Fica o rastro: GGT alta e leucócitos em queda.



O que o desenho não mostra: um segundo cálculo pode ter ficado no colédoco sem dilatá-lo. Só colangiorressonância ou ecoendoscopia respondem; a tomografia perde cálculos pequenos e pouco calcificados.

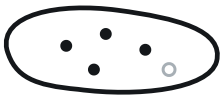


CÁLCULO QUE MIGROU

Encaixa em tudo

Obstrução de horas. Transaminases sobem e caem rápido; bilirrubina só sobe se a obstrução dura. Leucócitos acompanham a bile infectada e caem com a desobstrução.

DOR	Súbita, cólica, para o dorso, cede em horas.
ENZIMAS	AST e ALT 5 a 10 vezes o limite; GGT alta; FA sobe depois.
IMAGEM	Colédoco pode estar fino se o cálculo já passou.
PRÓXIMO PASSO	Colangiorressonância ou ecoendoscopia; CPRE só com cálculo visto.



HEPATITE AGUDA

Não encaixa na dor nem nos números

Lesão difusa e lenta. Começa com febre, mal-estar, náusea e anorexia; a dor, quando existe, é desconforto, não cólica. Na hepatite A sintomática a ALT fica em 5 a 15 vezes o limite ou mais, e a icterícia vem em poucos dias.

DOR	Surda, sem irradiação, depois do pródromo.
ENZIMAS	Sobem por dias, caem devagar; bilirrubina sobe junto.
IMAGEM	Fígado normal ou aumentado; via biliar normal.
PRÓXIMO PASSO	Anti-HAV IgM agora; anti-HEV e autoimunidade se o controle subir.

Às 15h30, a AST em queda diz que a agressão parou.

A coleta cai cerca de 21 horas após a dor. A AST tem meia-vida de 17 horas e a ALT, de 47: se a obstrução cessou em D0, a AST já vem em queda e a ALT pode estar estável, perto do pico. As duas subindo juntas não cabem no cálculo que passou. E a queda não prova colédoco limpo: melhora dos testes não previu passagem do cálculo nos estudos. A colangiorressonância fica de pé nos dois cenários.

AST CAIU, ALT ESTÁVEL

A obstrução cessou. Dá para desospitalizar.

Relação AST/ALT abaixo de 1, bilirrubina normal, sem dor nem febre: agressão resolvida; cálculo residual ainda não afastado.

IMAGEM	Colangiorressonância com data curta e marcada: cálculo que fica complica o dobro; em colecistectomizada, a CPRE é o tratamento definitivo.
ANTIBIÓTICO	Tóquio 2018: 4 a 7 dias após o controle da fonte, com troca para via oral em quem come. Contar a passagem espontânea como fonte controlada é extrapolação. Decisão do médico assistente.
RETORNO	Febre, icterícia, colúria ou dor de novo: voltar no mesmo dia.

AS DUAS SUBIRAM

Obstrução persiste, ou não é cálculo.

AST e ALT ainda em subida franca, ou bilirrubina agora alta: o colédoco segue obstruído, contínuo ou intermitente.

IMAGEM	Colangiorressonância ou ecoendoscopia antes da alta. CPRE só se mostrar cálculo.
ANTIBIÓTICO	Manter: colangite com fonte não controlada. Sem resposta em 24 h ou cálculo visto, Tóquio trata como grau II: drenagem precoce.
VIA FINA	Se a bilirrubina seguir normal e a imagem vier limpa: anti-HAV IgM e revisar fármacos; hepatite volta à lista.
SE REPETIR	Nova crise biliar com enzimas altas e imagem limpa: distúrbio do esfíncter de Oddi (Roma V, 2026), conduta eletiva em centro de referência. CPRE empírica não tem respaldo.

D0, até 6 h

AST 292, ALT 188: AST na frente, lesão em curso. Bilirrubina 0,8, lipase 52,6.

D1, manhã

AST 299, ALT 281: AST parou, ALT ainda sobe. Leucócitos de 18,8 para 14,5 mil.

15h30

Esperado se passou: AST bem abaixo de 299 e caindo; ALT estável perto de 281; relação AST/ALT abaixo de 1.

Estimativa pelas meias-vidas e por séries de obstrução aguda (AST cai 76% e ALT 58% em 72 h). A hora da coleta de D1 muda a conta.

Em aberto: provar que não sobrou cálculo.

O diagnóstico mais provável está firme. As diretrizes pedem agora imagem da via biliar sem CPRE: ultrassom e tomografia perdem boa parte dos cálculos, mais ainda abaixo de 5 mm.

Dúvidas ao médico

1. Valores de referência do laboratório para ALT, AST e GGT. Os múltiplos daqui usam 40 U/L.
2. Hora da coleta de D1. Define quanto a AST deveria ter caído até as 15h30.
3. "HEV" na conduta é hidratação venosa? Lido assim; se for hepatite E, muda a lista.
4. Ceftriaxona: dose única ou mantida? O cirurgião falou em manter; Tóquio prevê 4 a 7 dias.
5. Diâmetro do colédoco no ultrassom e na tomografia. Em colecistectomizada, a ASGE chama de dilatado acima de 8 mm e Roma V cita até 13 mm como normal; os laudos não trazem o número.

Passos

1. Coleta das 15h30 com bilirrubina total e frações, FA, GGT, PCR, albumina, lipase e anti-HAV IgM, além de AST e ALT.
2. AST caiu e ALT estável: alta com colangiorressonância marcada, orientação de retorno e definição do antibiótico.
3. As duas subiram: colangiorressonância ou ecoendoscopia antes da alta, discutir com cirurgia e endoscopia; CPRE só com cálculo visto.

O que acrescentar à coleta das 15h30

DECIDE

Bilirrubina total e frações

Nunca foi repetida. É o item que as diretrizes pesam para cálculo e colangite.

COMPLETA O QUADRO

FA e GGT | **PCR** | **Albumina** | **Lipase** | **Anti-HAV IgM**

FA e GGT: a colestase ainda cresce? PCR e albumina: critérios de Tóquio 2018. Lipase: a primeira pode ter sido colhida antes de subir. Anti-HAV IgM: a sorologia que falta.

POR QUE BILIRRUBINA NORMAL NÃO EXCLUI CÁLCULO

Na ASGE de 2019, bilirrubina acima de 4 mg/dL só é critério de alta probabilidade junto com colédoco dilatado. Testes hepáticos alterados, sozinhos, já põem a paciente na faixa intermediária, cuja resposta é colangiorressonância ou ecoendoscopia, não CPRE direta. Em séries de coledocolitíase, 4 em 10 tinham bilirrubina normal.

Fontes lidas em 31 de outubro de 2026: [FONTES]. Verificação item a item em verificacao-diretrizes.md. Sem dado identificável de paciente. A decisão clínica é do médico assistente.